d'évolution significative, avec 100 % des unités conformes. Le TCA, FII, FV, FX, protéines S et C, AT, plasminogène, α2-antiplasmine, ADAMTS13 et les paramètres de thrombogramme présentent une évolution statistiquement significative, mais dans le même sens et du même ordre de grandeur que l'évolution constatée sur les CQI. Les différences pourraient être attribuées à l'évolution analytique des couples automate/réactifs utilisés. Le plasma décongelé à 2 ans respecte les exigences définies pour le PFC.

Déclaration de liens d'intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d'intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.tracli.2019.06.027

P-021

Sécurité infectieuse : dépistage des infections virales des hépatites B et C chez les donneurs de sang du centre national de transfusion sanguine de Bamako, Mali

Amadou B. Diarra*, Hassana Guitteye, Djakaridja Traore, Gaoussou Togora, Minkoro Fomba, Moussa Cisse, N'falaye Kamissoko, Hafiza D. Guindo, Adama Traore, Bakary Maiga, Mounirou Baby
Centre National de Transfusion Sanguine, Bamako, Mali
* *Auteur correspondant.*
Adresse e-mail : amadoubdiarra@yahoo.fr (A.B. Diarra)

La prise en charge de nombreuses affections ne se conçoit pas sans possibilité de transfusion sanguine, or, cette thérapeutique n'est pas dénuée de risques notamment viraux. Au Mali, elle est largement utilisée, mais dans un contexte difficile, marqué par une insuffisance de ressources, c'est dans ce contexte que nous avons entrepris cette étude dont le but était de déterminer la prévalence des marqueurs infectieux VHB et VHC chez les donneurs de sang de Bamako. L'étude prospective transversale a été réalisée entre janvier et décembre 2017. Au total 48 508 dons de sang ont été testés à la recherche de l'antigène HBs et de l'anticorps anti VHC. La technique immuno-enzymatique ELISA a été utilisée avec des réactifs de quatrième génération. Le portage de l'antigène HBs a été de 10,72 % et la séroprévalence du VHC a été de 1,53 %. Les dons de sang de remplacement représentaient 73,69 % de l'ensemble des poches collectées avec les plus fortes prévalences des marqueurs sérologiques. Cette situation est comparable à beaucoup d'études réalisées au Mali et en Afrique subsaharienne. Il convient donc, d'intensifier les actions de promotion en faveur du don volontaire et bénévole, en vue d'abandonner progressivement le don de remplacement. Ceci est attesté pour le Mali et est sans doute valable pour la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne.

Déclaration de liens d'intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d'intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.tracli.2019.06.028

P-022

Évaluation in vitro du plasma atténué pour les agents pathogènes avec des dispositifs INTERCEPT sans phtalates

Anne-Gaele Chartois[1,*], Emmanuel Rivery[1], Marie Colombat[2], Yann Giraud[1], Frederic Dehaut[1]
[1] *EFS Centre Pays de la Loire, Nantes, France*
[2] *EFS Nouvelle Aquitaine, Bordeaux, France*
* *Auteur correspondant.*
Adresse e-mail : anne-gaele.chartois@efs.sante.fr (A.-G. Chartois)

Contexte Le dispositif d'atténuation des agents pathogènes dans le plasma INTERCEPT™ INT31 (Cerus), a été modifié afin de rendre le kit totalement exempt de DEHP. La surface de contact de la poche de stockage final a été augmentée pour diminuer la durée de décongélation des unités de plasma. La qualité in vitro des plasmas traités sur le dispositif INTERCEPT™ INT31 « Nouveau plastique » a été évaluée sur des unités de plasma frais congelé issu d'aphérèse (PFC-IA) et de mélanges de plasma frais issus de sang total (PFCM-IA).
Méthode 8 unités de plasma d'aphérèse et 8 mélanges de 5 plasmas issus de ST ont été traités respectivement dans les 16 heures et 17 heures après la fin des dons par le système INT31, répartis en 3 unités de 200 mL et congelés dans les 18 et 19 heures suivant le prélèvement. Le contenu cellulaire a été vérifié avant traitement. La qualité in vitro des PFC-IA a été évaluée pour l'amotosalen résiduel, les taux de FVIII, de fibrinogène de protides, de C3a, de C5a et les complexes TAT, avant traitement et après 6 à 12 jours de stockage à −25 °C.
Résultats Les plasmas PFC-IA et PFCM-IA étaient conformes aux exigences réglementaires françaises. Un PFC-IA présentait un taux de fibrinogène inférieur à 2,0 g/L mais > 70 % (94 %) des unités traitées étaient bien supérieures à cette limite. La durée de décongélation des unités dans un bain-marie à 37 °C était de 6 à 7 minutes.
Conclusion Les unités de PFC-IA et PFCM-IA préparées avec le dispositif de traitement INTERCEPT intégralement non-DEHP conservent des caractéristiques in vitro répondant aux normes de qualité pour le plasma thérapeutique. Le processus n'active ni la coagulation ni le complément (Tableau 1).

Tableau 1 Paramètres biologiques évalués.

	PFC-Aphérèse	
	Avant Inactivation	PFC-IA
Facteur VIII (UI/mL)	1.3 ± 0.3	0.9 ± 0.2
Fibrinogène (g/L)	2.5 ± 0.5	2.2 ± 0.4
TAT (ng/mL)	2.7 ± 0.3	2.6 ± 0.4
Protéines (g/L)	61.7 ± 2.3	60.7 ± 2.1
C3a (ng/mL)	772.2 ± 139.9	32.2 ± 13.8
C5a (ng/mL)	17.9 ± 7.1	11.8 ± 5.3
	PFC-ST	
	Avant Inactivation	PFCM-IA
Facteur VIII (UI/mL)	1.0 ± 0.2	0.8 ± 0.1
Fibrinogène (g/L)	2.6 ± 0.2	2.4 ± 0.2
TAT (ng/mL)	33.6 ± 15.1	30.6 ± 12.6
Protéines (g/L)	60.1 ± 1.5	58.8 ± 1.6
C3a (ng/mL)	192.1 ± 50.7	14.6 ± 4.0
C5a (ng/mL)	9.3 ± 1.1	6.9 ± 0.8

Déclaration de liens d'intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d'intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.tracli.2019.06.029

P-023

Contrôle statistique de la procédure de filtration en ligne

Paola Scrofani, Giancarla Barrotta, Guglielmo Giuca, Simone Travali*, Giovanni Garozzo
A.S.P. n. 7 Ragusa, Ragusa, Italie
* *Auteur correspondant.*
Adresse e-mail : simone.travali@asp.rg.it (S. Travali)

Auprès du Service de Transfusion de Ragusa a été réalisé un suivi statistique de la procédure de filtration en ligne pour démontrer que le changement de la méthodologie, comme l'Introduction du nouveau système de filtration COMPOFLOW SELECT CQ31555, a donné les résultats attendus. Soixante-quinze hématies filtrées pré-storage ont été soumises à un contrôle. Pour chaque unité on a enregistré les poids des hématies concentrées, les valeurs de Hb, HCT, nombre de leucocytes résidus. Pour mesurer l'efficacité d'un procédé de production sont utilisés les indices de capacités: l'indice Cp et le Cpk. Pour le HCT le Cpk = (2.519; 2.638) résulte majeur de 1, l'ampleur des données se situe